

冠心病稳定型心绞痛中医诊疗指南

编号：SATCM-2019-XX (XXX)

编制说明

提出单位：中华中医药学会

归口单位：中华中医药学会

项目承担单位：中国中医科学院广安门医院

项目工作组成员：王阶 孙建宁 何丽云

毛静远 朱明军 刘中勇 刘红旭林谦

黄力 衷敬柏 李军 姚魁武

《冠心病稳定型心绞痛中医诊疗指南》编制组

二〇一九年六月

目录

一、背景介绍.....	4
（一）任务背景.....	4
（二）任务参加单位.....	4
二、专家委员会及工作组.....	4
（一）指南指导委员会.....	5
（二）方法学专家.....	5
（三）疾病领域专家委员会.....	5
（四）主要起草人.....	5
（五）系统评价组.....	6
（六）秘书处.....	6
三、主要工作过程.....	6
（一）启动.....	6
（二）起草.....	7
1. 组织管理.....	7
2. 利益冲突声明.....	7
3. 定义临床问题.....	7
4. 确定临床问题清单.....	7
5. 收集证据与系统评价.....	8
6. 证据质量评价.....	9
7. 形成推荐意见.....	9
8. 指导委员会修改.....	9
9. 指南质量评价.....	10
（三）征求意见.....	10
四、技术内容的确认方法与依据.....	10
（一）总体内容.....	10
（二）内容分解.....	10
五、与相关法律、法规和强制性标准的关系.....	10
六、重大分期意见的处理经过和依据.....	10

七、作为推荐性标准的建议.....	10
八、贯彻标准的要求和措施建议.....	10
九、指南更新计划.....	11
十、附件.....	11

一、背景介绍

（一）任务背景

冠心病（coronary atherosclerotic heart disease, CAHD）是指由于冠状动脉粥样硬化使管腔狭窄或阻塞导致心肌缺血、缺氧而引发的心脏病，是动脉粥样硬化导致器官病变的最常见类型。1979 年世界卫生组织将其分为心绞痛、无症状性心肌缺血、心肌梗死、猝死、缺血性心肌病。心绞痛是指冠状动脉供血不足，心肌急剧的、暂时的缺血与缺氧所引起的临床综合征。其中，稳定型心绞痛（stable angina pectoris, SAP）最为常见，其发作程度、发作频率、性质及诱发因素在 1-3 个月内无明显变化。CAHD 已成为全球亟待解决的重大卫生问题。目前，全球 CAHD 患病人数估计为 1.1 亿，低中收入国家呈上升趋势；因 CAHD 死亡人数估计为 892 万，CAHD 年龄标化死亡率男性人群为 173/10 万，女性人群为 115/10 万。我国 CAHD 死亡占比由 1990 年的 8.6% 增加至 2013 年的 15.2%；同期，CAHD 死亡在所有心血管疾病死亡中的比例由 29% 增加至 37%；CAHD 已经在我国六个省、直辖市/省级行政区成为首位死亡原因。SAP 属于中医学“胸痹”“心痛”范畴，中医药对于该病的治疗积累了大量经验，但目前缺乏必要的可用于指导临床诊疗的标准规范。

为提高中医药防治 SAP 的水平，规范中医药在冠心病稳定型心绞痛中的应用，中华中医药学会心血管病分会组织相关专家，参照国际最新的临床实践指南制订方法，并在相关法律法规和技术文件指导的框架下，以传统中医辨证论治为基本点，结合循证医学原理，在古今文献回顾分析、临床流行病学调查、中成药系统综述、名老中医经验总结、专家咨询等系统研究工作基础上，对冠心病稳定型心绞痛的基本证候特点、辨证用药规律等进行了梳理、归纳、总结，并经讨论制定《冠心病稳定型心绞痛中医诊疗指南》，以期从事冠心病防治的中医、中西医结合临床医师提供指导性意见。

（二）任务参加单位

参与起草单位包括：中国中医科学院广安门医院、北京中医药大学中药学院、中国中医科学院中医临床基础医学研究所、天津中医药大学第一附属医院、河南中医药大学第一附属医院、江西中医药大学附属医院、首都医科大学附属北京中医医院、北京中医药大学东直门医院、中日友好医院、中国中医科学院西苑医院、中国医学科学院阜外医院、首都医科大学附属北京安贞医院

二、专家委员会及工作组

（一）指南指导委员会

路志正 中国中医科学院广安门医院
薛伯寿 中国中医科学院广安门医院
吴以岭 河北医科大学
葛均波 中国科学技术大学附属第一医院
韩雅玲 解放军沈阳军区总医院全军心血管病研究所
李丽 人民卫生出版社
张科 人民卫生出版社
刘国正 中医杂志社
焦爽 中医杂志社

（二）方法学专家

何丽云 中国中医科学院中医临床基础医学研究所
张誉清 麦克马斯特大学McMaster University
孙凤 北京大学循证医学中心
李霞 中国中医科学院中医药信息研究所

（三）疾病领域专家委员会

毛威、邓悦、邢雁伟、刘中勇、刘红旭、刘建和、
安冬青、许滔、李大奇、李军、李应东、李易、
李莉、吴伟、吴欣媛、张艳、张振鹏、张晶、
陈金水、陈恒文、冼绍祥、胡荣、聂绍平、徐惠梅、
衷敬柏、唐健元、唐熠达、黄力、薛一涛

（四）主要起草人

王阶 中国中医科学院广安门医院
孙建宁 北京中医药大学中药学院
何丽云 中国中医科学院中医临床基础医学研究所
毛静远 天津中医药大学第一附属医院
朱明军 河南中医药大学第一附属医院
刘中勇 江西中医药大学附属医院
刘红旭 首都医科大学附属北京中医医院
林谦 北京中医药大学东直门医院
黄力 中日友好医院
衷敬柏 中国中医科学院西苑医院
唐熠达 中国医学科学院阜外医院
蔡军 中国医学科学院阜外医院
胡奉环 中国医学科学院阜外医院

聂绍平 首都医科大学附属北京安贞医院
胡荣 首都医科大学附属北京安贞医院
李 军 中国中医科学院广安门医院
姚魁武 中国中医科学院广安门医院
邢雁伟 中国中医科学院广安门医院
张振鹏 中国中医科学院广安门医院
何庆勇 中国中医科学院广安门医院
熊兴江 中国中医科学院广安门医院
刘咏梅 中国中医科学院广安门医院

（五）系统评价组

陈 光 中国中医科学院广安门医院
何浩强 中国中医科学院广安门医院
胡 骏 中国中医科学院广安门医院
王靖怡 中国中医科学院广安门医院
何俊明 中国中医科学院广安门医院
胡 坤 中国中医科学院广安门医院
解紫从 中国中医科学院广安门医院
陆炳旭 中国中医科学院广安门医院
朱 爽 中国中医科学院广安门医院
李洪峥 中国中医科学院广安门医院
杨 光 中国中医科学院广安门医院
谌子诺 中国中医科学院广安门医院
刘兰椿 中国中医科学院广安门医院
傅梦薇 中国中医科学院广安门医院

（六）秘书处

陈 光、何浩强、胡 骏、王靖怡

三、主要工作过程

（一）启动

2019年3月18日，王阶教授在中国中医科学院广安门医院召开“冠心病稳定型心绞痛中医诊疗指南”项目讨论会，会议确定向中华中医药学会标准化委员会申请《冠心病稳定型心绞痛中医诊疗指南》的立项，并确立了由临床医师、护理人员、药学专家、方法学专家、卫生经济学专家、信息学专家、患者代表共同构成起草组。为保证项目进度，制定了指南编制工作时间节点，见表1。2019年4月18日通过中华中医药学

会团体标准立项论证会的论证，并按照专家意见对立项申请书进行修订，经中华中医药学会秘书长办公会审议批准，2019 年 5 月 10 日发文正式立项（附件 1：中华中医药学会团体标准立项公告）。

表 1 《冠心病稳定型心绞痛中医诊疗指南》指南制定工作时间节点

2019.3-2019.5	2019.5-2019.6	2019.6-2019.7	2019.7
成立指南起草组； 组织管理； 申请立项；	定义临床问题； 检索已有系统综述并质量评价； 收集证据与系统评价； 证据质量评价； 患者意愿调查；	专家共识会议形成推荐意见强度； 公开征求意见；	送审会议审查

（二）起草

1. 组织管理

2019 年 5 月 6 日王阶教授在中国中医科学院广安门医院召开“冠心病稳定型心绞痛中医诊疗指南”项目组织管理讨论会，指南秘书详细介绍项目任务与计划安排，会议确定本指南设置起草工作组、系统评价小组、共识会议专家组、指导委员会、秘书处。

2. 利益冲突声明

本指南所有参与成员均签署本指南的利益冲突声明（附件 2：利益冲突声明表）。

3. 定义临床问题

第一，中医药干预冠心病稳定型心绞痛的成年人群是否需要再辨析证候进行治疗？

第二，对于冠心病稳定型心绞痛的成年人群，与常规基础治疗比较，在常规基础治疗上加用中医药干预措施，对改善心绞痛症状、改善生活质量、预防斑块进展、预防心血管终点事件的效果如何？（中医药干预措施包括：常用汤剂 16 首，中成药 24 种，注射剂 5 种，非药物疗法 4 种）即回答“对于什么特征的稳定型心绞痛人群，冠心病的什么阶段，如何使用中医药干预措施，可以发挥什么优势”的问题。

4. 确定临床问题清单

第一，在冠心病稳定型心绞痛的成年患者中，与常规基础治疗比较，在常规基础治疗上加用中医药干预措施，对改善症状和缺血发作的效果如何？

第二，在冠心病稳定型心绞痛的成年患者中，与常规基础治疗比较，

在常规基础治疗上加用中医药干预措施，对预防心血管终点事件发生的效果如何？

第三，在冠心病稳定型心绞痛的成年患者中，与常规基础治疗比较，在常规基础治疗上加用中医药干预措施，对改善生活质量的效果如何？

第四，在冠心病稳定型心绞痛的成年患者中，与常规基础治疗比较，在常规基础治疗上加用中医药干预措施，对运动条件下最大运动耐受时间的效果如何？

第五，在冠心病稳定型心绞痛的成年患者中，与常规基础治疗比较，在常规基础治疗上加用中医药干预措施，对预防斑块进展的效果如何？

具体中医药干预措施包括方剂、中成药、注射剂、非药物疗法。方剂：冠心 2 号方、瓜蒌薤白半夏汤、失笑散、温胆汤、黄连温胆汤、涤痰汤、宽胸丸、八珍汤、生脉散、左归饮、酸枣仁汤、黄连阿胶汤、真武汤、参附汤合右归饮。中成药：速效救心丸、复方丹参滴丸、血府逐瘀胶囊、冠心苏合丸、通心络胶囊、参松养心胶囊、心元胶囊、宽胸气雾剂、麝香保心丸、血塞通软胶囊、冠心舒通胶囊、心可舒片、丹蒺片、脑心通胶囊、养心氏片、天王补心丹。银丹心脑通胶囊、养心达瓦依米西克蜜膏。注射剂：参附注射液、丹红注射液、灯盏细辛注射液、生脉注射液、注射用红花黄色素。非药物疗法：针刺、艾灸、太极拳、八段锦。

5. 收集证据与系统评价

2019 年 5 月 24 日王阶教授在中国中医科学院广安门医院召开“冠心病稳定型心绞痛中医诊疗指南”项目系统评价方法讨论会，确定采用 GRADE 方法学，并确立体现中医药特色的方法要点。

第一，根据问题清单，构建 PICOS 问题。P 限定为冠心病稳定型心绞痛患者，I 为问题清单中的中医药干预措施，C 为常规基础治疗，O 限定主要结局指标为缓解症状与改善预后问题，S 限定为随机对照试验。

第二，根据 PICOS 问题制定检索策略与文献纳入排除标准。

检索数据库：中国生物医学文献数据库（CBM）、中国知网（CNKI）、万方数据库、维普数据库、Medline、Embase、Cochrane。

检索式：附件 3。

原始研究纳入排除标准：附件 4。

第三，采集纳入文献的基本信息，对 meta 分析进行质量评价，对原始研究进行 Meta 分析与 ROB 质量评价

Meta 分析的质量评价采用 AMSTAR 量表。每个条目评价结果分“是”、“否”、“不清楚或未提及”三种，“是”为 1 分，“否”、“不清楚

或未提及”为0分，共11分。AMSTAR 量表得分0~4分为低质量，5~8分为中等质量，9~11分为高质量。

ROB质量评价：根据Cochrane手册中的“偏倚风险评估”工具对进行评价：①随机序列生成；②随机隐藏；③患者和工作人员盲法；④结局评价者盲法；⑤不完整结局数据；⑥选择性报告结局；⑦其他偏倚。最终给出“偏倚风险低”、“偏倚风险高”、“偏倚风险不确定”的判断。

6. 证据质量评价

证据质量是对合并效应量预测值的真实性的把握程度，GRADE 系统将证据质量分为高、中、低、极低4级，基于RCT得出的证据开始定义为高质量，但可以因研究的局限性、研究结果不一致、间接证据、结果不精确、报告偏倚5个因素而降级；基于观察性研究的证据开始定义为低质量，但可以因疗效显著、存在剂量效应关系、存在各种可能导致疗效显著性降低的偏倚3个因素而升级。最终形成结果总结表与证据概要表（附件5：GRADE 评级及证据概要表）。

7. 形成推荐意见

采用专家共识会议法对证据形成推荐意见。本指南主要起草人、临床专家组、方法学组中来自全国15个省市自治区的27位专家以及2位患者代表参与了共识会议，共识会议由三部分组成，首先由指南主席王阶教授向与会者介绍该指南的背景、立项到完成GRADE分级的全过程，其次由指南秘书陈光博士介绍该指南的方法学以及证据概要，最后由王阶教授主持共识会的投票过程。推荐意见考虑因素：实施后所带来的利弊、患者的价值观与意愿（患者意向调查结果）、需要的临床条件与实践中的差距、地域符合情况、成本-效果分析。本指南的共识表格基于GRADEGRID（附件6、附件7），分三轮进行投票，达成共识规则如下：若除了“0”以外的任何一格票数超过50%，则视为达成，可直接确定推荐意见方向及强度；若“0”某一侧两个总票数超过70%，亦视为达成共识，可确定推荐方向，推荐强度直接定为“弱”；其余情况视为未达成共识，推荐意见进入下一轮投票。最终，由指南秘书处统计并汇总推荐意见及强度。

8. 指导委员会修改

推荐意见形成第二天，指南指导委员会成员路志正、薛伯寿、吴以岭、葛均波、韩雅玲、李丽、张科、刘国正、焦爽，对达成的推荐意见逐一进行审核，审核小组按照指南评审要求和流程，批准了64条达成共识的推荐意见。

9. 指南质量评价

根据指南研究与评价工具（Appraisal of Guidelines, Research and Evaluation in Europe, AGREE）II 框架下的中国临床指南评价体系（AGREE-China）对本指南进行质量评价，包括 5 个领域共 15 个条目，参考每一条目的赋分与权重，本指南得分为 98 分。

（三）征求意见

征求意见采用信函征求意见与网上公开征求意见两种形式（附件 8：征求意见反馈表）。信函征求意见覆盖全国 29 个省市自治区的心血管科临床专家。

四、技术内容的确认方法与依据

（一）总体内容

指南正文共设 10 部分，主要技术内容有范围、规范性引用文件、术语及定义、流行病学特点、诊断、病因病机、辨证论治、针灸治疗、心脏康复、预防调摄。

（二）内容分解

第 1 部分 明确该指南适用范围和适用对象。

第 2 部分 列出该指南主要引用的标准规范文件。

第 3 部分规定该指南的术语和定义。

第 4 部分介绍冠心病稳定型心绞痛的流行病学特点。

第 5 部分介绍本病的诊断，包括诊断依据、疾病分期、严重程度评估。

第 6 部分介绍本病病因病机。

第 7 部分介绍本病辨证论治，包括发作期、缓解期治疗建议。

第 8 部分介绍本病的针灸治法。

第 9 部分介绍心脏康内容。

第 10 部分介绍了预防调摄。

五、与相关法律、法规和强制性标准的关系

目前已有《心绞痛 X—综合征（微血管型心绞痛）》、《冠心病心绞痛》、《胸痛（不稳定心绞痛）》冠心病相关的团体标准，本指南适用人群为冠心病稳定型心绞痛，与现行的法律、法规和强制性标准没有冲突。

六、重大分期意见的处理经过和依据

本指南制订过程中，无重大分歧意见。

七、作为推荐性标准的建议

建议作为推荐性行业标准发布。

八、贯彻标准的要求和措施建议

建议在中华中医药学会官方网站、微信平台，期刊论文发布，并通过培训等方式贯彻实施、推广应用。

九、指南更新计划

本指南计划 3 年后进行更新，更新方案主要涉及干预措施的种类、证据等级以及推荐强度。

十、附件

附件 1：冠心病稳定型心绞痛中医诊疗指南-立项公告

附件 2：利益冲突声明表

附件 3：检索式

附件 4：原始研究纳入排除标准

附件 5：GRADE 评级及证据概要表

附件 6：冠心病稳定型心绞痛发作期推荐 GRADE 网格

附件 7：冠心病稳定型心绞痛缓解期推荐 GRADE 网格

附件 8：征求意见反馈表

附件 1：立项公告

中华中医药学会

中华中医药学会团体标准

立 项 公 告

China Association of Chinese Medicine

Announcement for Standards

中华中医药学会批准《冠心病稳定型心绞痛中医诊疗指南》立项，
现予公告。

The T/CACM standard for Guideline for Diagnosis and Treatment of Chinese Medicine in Stable Anginain Coronary Artery Disease was initiated by the China Association of Chinese Medicine, and now it is effective.

China Association of Chinese Medicine



附件 2:

冠心病稳定型心绞痛中医诊疗指南利益冲突声明表

姓名		机构	
职称		职务	
专业领域		工作年限	
联系电话		邮箱	
通讯地址			

- 所有指南指导委员会和指南制定小组的专家必须声明所有潜在的利益冲突（如：所有影响或可能影响专家客观性和独立性的利益）。
- 您必须在这张利益声明表上声明所有和本部指南主题相关的任何商业的、专业的或其他方面的利益，和所有可能被本部指南成果影响的利益。

过去 3 年间	
我持有与该指南中干预措施有利益关系的公司的股票	是 ☐ 否 ☐
我应邀担任过与该指南中干预措施有利益关系的公司的顾问并接受相应酬劳	是 ☐ 否 ☐
我接受过与该指南中干预措施有利益关系的公司的研究经费	是 ☐ 否 ☐
我接受过与该指南中干预措施有利益关系的公司大于 1 万元的其他费用（如差旅费等）	是 ☐ 否 ☐
我与该指南存在学术上或专业上的利益关联，可能影响指南制定的客观性	是 ☐ 否 ☐

- 除上述内容，在过去的 3 年内，您还有什么需要申报的内容，请于下框填写。

--

- 如果上述任何问题您的答案为“是”，请在下框中给予简要的解释。

--

- 利益声明发表知情：我同意将上述完成内容公开给其他指南制定成员，并同意该利益声明表在指南中发表。
- 声明：我承诺我所声明的内容是真实而完整的。如果上述我所声明的信息在任何时间发生任何变动，我将迅速告知指南秘书组并完成一份新的利益声明表。

签名：_____日期：_____

附件 3：检索式

1. 中国生物医学文献数据库 (CBM)

关键词

("稳定型心绞痛" OR "稳定性心绞痛" OR "心绞痛" OR "冠状动脉粥样硬化性心脏病" OR "冠心病" OR "冠状动脉粥样硬化" OR "胸痹" OR "心痛" OR "胸痛") AND ("干预措施")

2. 中国知网 (CNKI)

SU=('稳定性心绞痛'+ '稳定型心绞痛'+ '心绞痛'+ '冠心病'+ '冠状动脉粥样硬化性心脏病'+ '冠状动脉粥样硬化'+ '胸痹'+ '胸痛'+ '心痛')*('干预策略') AND FT=('随机')

3. 万方数据库 (WangFang)

题名或关键词: (("稳定型心绞痛" + "稳定性心绞痛" + "心绞痛" + "冠状动脉粥样硬化性心脏病" + "冠心病" + "冠状动脉粥样硬化" + "冠状动脉粥样硬化" + "胸痹" + "心痛" + "胸痛")*("干预措施"))*全部: ("随机")

4. 维普数据库 (VIP)

(M=(稳定型心绞痛 OR 稳定性心绞痛 OR 心绞痛 OR 冠状动脉粥样硬化性心脏病 OR 冠心病 OR 冠状动脉粥样硬化 OR 胸痹 OR 心痛 OR 胸痛)) AND (M=(干预措施)) AND R=随机

5. Medline

Search (((("Angina, Stable"[Mesh]) OR (((((((((((((((Anginas, Stable[Title/Abstract]) OR Stable Angina[Title/Abstract]) OR Stable Anginas[Title/Abstract]) OR Chronic Stable Angina[Title/Abstract]) OR Angina, Chronic Stable[Title/Abstract]) OR Anginas, Chronic Stable[Title/Abstract]) OR Chronic Stable Anginas[Title/Abstract]) OR Stable Angina, Chronic[Title/Abstract]) OR Stable Anginas, Chronic[Title/Abstract]) OR Angina Pectoris, Stable[Title/Abstract]) OR Angina Pectori, Stable[Title/Abstract]) OR Pectori, Stable Angina[Title/Abstract]) OR Pectoris, Stable Angina[Title/Abstract]) OR Stable Angina Pectori[Title/Abstract]) OR Stable Angina Pectoris[Title/Abstract]))) AND (((randomized controlled trial[Publication Type]) OR randomized[Title/Abstract]) OR placebo[Title/Abstract])) AND (((danhong[Title/Abstract]) OR 干预措施[Title/Abstract]))

6. Embase

#1 'anginas, stable' OR 'stable angina':ab OR 'stable anginas' OR 'chronic stable angina' OR 'angina, chronic stable' OR 'anginas, chronic stable' OR 'chronic stable anginas' OR 'stable angina, chronic' OR 'stable anginas, chronic' OR 'angina pectoris, stable' OR 'angina pectori, stable' OR 'pectori, stable angina' OR 'pectoris, stable angina' OR 'stable angina pectori' OR 'stable angina pectoris':ab,ti

#2 '干预措施'

#3 'Randomized' OR 'placebo' OR 'Randomly' OR 'trial' OR 'goups' [ti,ab]

#4 'Randomized controlled trial' OR 'controlled clinical trial' [pt]

#5 #3 OR #4
#6 #1AND #2AND#5

7. Cochrane

#1 MeSH descriptor: [Angina Pectoris]
#2 (干预措施):ti,ab,kw
#3 (randomized):ti,ab,kw
#4 #1 AND #2 AND #3

附件 4:

原始文献纳入排除标准

1. 纳入标准:

受试者:

- ①稳定性心绞痛发作, CAD 相关呼吸困难等症状发作 (特点: 一定心脏负荷的可恢复的心肌供血不足);
- ②之前有症状, 药物治疗或血管重建后无症状;
- ③微血管病变
- ④血管痉挛

2. 结局指标:

- ①心绞痛发作时减轻症状, 停止发作;
- ②预防心绞痛发作;
- ③降低病死率;
- ④降低心血管事件发生率;
- ⑤稳定斑块;
- ⑥较少斑块进展;
- ⑦预防血栓形成;
- ⑧改善中医证候相关症状体征;
- ⑨改善生活质量;
- ⑩改善常规西医药物治疗的副作用, 如 ED 等。
- ⑪布鲁斯平板运动试验条件下最大运动耐受时间的改变

3. 排除标准:

受试者: 急性冠脉综合征

对照: 对照组包括中医药干预措施。

附件 5:

GRADE 评级及证据概要表

1. GRADE 证据质量分级及定义

本指南采用 2004 年制订的推荐分级的评估、制定和评价(The Grading of Recommendations Assessment Development and Evaluation, GRADE)标准进行证据质量分级。

表 1 GRADE 证据质量分级及定义

质量等级	定义
高 (A)	非常确信观察值接近真实值, 进一步研究不大可能改变该观察值的可信度。
中 (B)	对观察值有中等强度信息: 真实值有可能接近观察值, 但仍存在两者不同的可能性, 进一步研究可能改变观察值的可信度, 且可能改变该观察值的结果。
低 (C)	对观察值的确信程度有限: 真实值可能与观察值差别很大, 进一步研究极有可能改变观察值的可信度, 且很可能改变该观察值的结果。
极低 (D)	对观察值几乎没有信息: 真实值很可能与观察值不同, 真实值可能与观察值有很大差别, 观察值的结果很不确定。

2. 推荐意见强度的定义

本指南推荐强度标准综合临床试验、中医古籍、医保目录、中国药典等标准化文件形成证据, 结合临床专家调研结果、药品说明书信息、患者偏好与价值观以及相关经济学分析数据, 由名义组会议专家综合权衡后作出推荐强度。

表 2 推荐意见强度的定义

强弱推荐使用	定义
强推荐使用	对于临床医生, 多数医生会选择使用该推荐意见; 对于患者, 绝大多数患者会采纳推荐意见, 只有少数不会; 对于政策制定者, 大多数情况会采纳推荐意见作为政策。
弱推荐使用	对于临床医生, 应认识到不同患者有各自适合的方案, 需要帮

助每个患者做出体现其价值观和意愿的决定；对于患者，大多数患者会采纳推荐意见，但仍有不少患者不采用；对于政策制定者，制定政策需要实质性讨论，并需要众多利益相关参与。

表 3 证据概要总结表（二分类变量）
冠心病稳定型心绞痛的 GRADE 证据概要表

分期	归属证候	主治证候	药物名称	质量评价						结果总结					
				研究数量及设计	局限性	不一致性	间接性	不精确性	发表偏倚	病例数		相对危险度（95%CI）	绝对危险		质量
										对照组	试验组		对照组危险度	危险度差（95%CI）	
发 作 期			宽胸气雾剂	5 分钟缓解率（1 个 RCT）	无严重局限性	无严重不一致性	无严重间接性	严重不精确性	未发现	17/43	19/43	1.21 (0.51, 2.86)	395/1000	无统计学意义	+++—中
				3 分钟缓解率（1 个 RCT）	无严重局限性	无严重不一致性	无严重间接性	严重不精确性	未发现	13/43	22/43	2.42 (1, 5.85)	302/1000	无统计学意义	+++—中
				不良反应（1 个 RCT）	无严重局限性	无严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	未发现	15/43	4/43	0.19 (0.06, 0.64)	349/1000	低于 257/1000 (94, 318)	++++高
			速效救心丸	心绞痛疗效（24 个 RCT）	无严重局限性	无严重不一致性	有严重间接性	无严重不精确性	未发现	1018/1302	1056/1704	2.84 (2.15, 3.76)	780/1000	高于 130/1000（104, 150）	+++—中
				心电图疗效（19	无严重局限性	无严重不一致性	有严重间	无严重不	未发现	577/1077	917/1431	1.67 (1.35, 2.07)	53.3/1000	高于 123/10	+++—中

				个 RCT)		性	接性	精 确 性				)		00 (73,1 70)	
			复方 丹参 滴丸	心 绞 痛 疗效 (9 个 RCT)	有严重 局限性	无严重 不一致 性	无 严 重 间 接性	无 严 重 不 确 精 性	未发 现	330/4 24	451/5 02	2.06(1. 03,4.12)	775/10 00	高 于 101/10 00 (5,15 9)	+++ - 中
				心 电 图 疗效 (9 个 RCT)	有严重 局限性	无严重 不一致 性	无 严 重 间 接性	无 严 重 不 确 精 性	未发 现	172/3 06	271/3 76	1.92(1. 23,3)	53.3/1 000	高 于 153/10 00 (51,2 39)	+++ - 中
发 作 期/缓 解期		气滞 血瘀	麝香 保心 丸	急 性 心 梗 发 生 率 (5 个 RCT)	无严重 局限性	无严重 不一致 性	严 重 间 接 性	无 严 重 不 确 精 性	未发 现	44/35 4	15/35 5	0.35(0. 2,0.6)	171/10 00	低 于 111/10 00 (68,1 37)	+++ - 中
				心 衰 发 生 率 (4 个 RCT)	无严重 局限性	严重不 一致性	无 严 重 间 接性	无 严 重 不 确 精 性	未发 现	54/23 4	19/23 5	0.36(0. 22,0.58)	225/10 00	低 于 144/10 00 (94,1 75)	+++ - 中
				住 院 率 降 低 (2 个 RCT)	无严重 局限性	严重不 一致性	无 严 重 间 接性	无 严 重 不 确 精 性	未发 现	34/10 9	13/11 0	0.38(0. 21,0.67)	378/10 0	低 于 234/10 00 (125, 299)	+++ - 中

				ACS 复发率 (2 个 RCT)	无严重局限性	无严重不一致性	严重间接性	无严重不精确性	未发现	33/196	12/197	0.36(0.19,0.67)	188/1000	低于 120/1000 (62,152)	+++ 中
				心绞痛疗效 (9 个 RCT)	无严重局限性	严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	未发现	394/537	490/546	1.19(1.13,1.26)	700/1000	高于 133 (91,181)	+++ 中
				心电图疗效 (6 个 RCT)	无严重局限性	严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	未发现	215/362	278/372	1.25(1.13,1.39)	607/1000	高于 152/1000 (79,237)	+++ 中
				不良事件 (4 个 RCT)	无严重局限性	严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	未发现	48/320	55/321	1.14(0.82,1.59)	84/1000	高于 12/1000 (15,50)	+++ 中
缓解期	心血瘀阻	心血瘀阻	冠心病 2 号方	心绞痛疗效 (7 个 RCT)	严重局限	无严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	未发现	337/423	480/510	1.18(1.12,1.25)	797/1000	高于 143/1000 (95,100)	+++ 中
				心电图疗效 (6 个 RCT)	无严重局限性	无严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	未发现	177/329	309/410	1.37(1.23,1.53)	538/1000	高于 199/1000 (124,285)	+++ 中

				不良反 应（3个 RCT）	无严重 局限	无严重 不一致 性	无严重 间接性	无严重 不精确 性	未发现	7/125	18/13 6	2.41(1. 11,5.22)	56/100 0	高于 79/100 0 (6,236)	++++ 高
				证候疗 效（2个 RCT）	无严重 局限	无严重 不一致 性	无严重 间接性	无严重 不精确 性	未发现	62/94	82/94	1.32(1. 12,1.56)	652/10 00	高于 211/10 00 (79,36 9)	++++ 高
缓 解 期	心血 瘀阻	瘀血 闭阻	丹红 注射液	心绞痛 疗效（5 个RCT）	严重局 限性	无严重 不一致 性	无严重 间接性	无严重 不精确 性	未发现	249/3 56	347/3 80	1.3(1.1 8,1.43)	700/10 00	高于 210/10 00 (126, 301)	+++ 中
		心血 瘀阻	冠心 舒通 胶囊	心绞痛 疗效（8 个RCT）	无严重 局限性	无严重 不一致 性	严重接 间接性	无严重 不精确 性	未发现	259/3 43	319/3 42	1.24(1. 16,1.32)	755/10 00	高于 181/10 00 (121, 242)	+++ 中
				心电图 疗效（6 个RCT）	无严重 局限性	无严重 不一致 性	严重接 间接性	无严重 不精确 性	未发现	188/2 70	231/2 72	1.22(1. 11,1.34)	696/10 00	高于 153/10 00 (77,2 37)	+++ 中
		心血 瘀阻	灯盏 细辛 注射液	心血管 事件（2 个RCT）	无严重 局限性	无严重 不一致 性	严重接 间接性	无严重 不精确 性	未发现	33/10 1	14/10 1	0.33(0. 16,0.67)	327/10 00	低于 189/10 00 (81,25	+++ 中

														5)	
				临床疗效（28个RCT）	无严重局限性	无严重不一致性	严重间接性	无严重不精确性	严重发表偏倚 ³	1038/1390	1329/1442	3.97(3.15, 5.02)	747/1000	高于175/1000(156, 190)	++--低
				心电图疗效（22个RCT）	无严重局限性	无严重不一致性	严重间接性	无严重不精确性	严重发表偏倚 ³	692/1136	901/1179	2.21(1.83, 2.68)	609/1000	高于166/1000(131, 198)	++--低
		心血瘀阻	血塞通软胶囊	心绞痛疗效（3个RCT）	严重局限性	无严重不一致性	严重间接性	无严重不精确性	未发现	118/148	135/150	1.13(1.03, 1.24)	800/1000	高于104/1000(24, 192)	++--低
				心电图疗效（2个RCT）	严重局限性	无严重不一致性	严重间接性	无严重不精确性	未发现	76/151	95/153	1.24(1.03, 1.49)	628/1000	高于151/1000(19, 308)	++--低
		心血瘀阻	注射用红花黄色素	心绞痛疗效（4个RCT）	无严重局限性	无严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	未发现	142/188	170/197	1.14(1.03, 1.26)	615/1000	高于203/1000(25, 437)	++++高

				心电图疗效（2个RCT）	无严重局限性	无严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	未发现	74/98	83/99	1.11(0.96,1.28)	712/1000	高于199/1000(43,392)	++++高
				不良事件（1个RCT）	无严重局限性	无严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	未发现	0/50	1/57	无统计学意义	无统计学意义	无统计学意义	++++高
				中医症状疗效（2个RCT）	无严重局限性	无严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	未发现	74/98	83/99	1.11(0.96,1.28)	757/1000	高于83/1000(30,212)	++++高
		瘀血内阻	地奥心血康胶囊	心电图疗效（6个RCT）	无严重局限性	无严重不一致性	有严重间接性	无严重不精确性	未发现	112/179	199/231	1.41(1.23,1.60)	632/1000	高于259/1000(145,379)	++++中
缓解期	心血瘀阻	瘀血内阻	地奥心血康胶囊	心绞痛疗效（9个RCT）	无严重局限性	无严重不一致性	有严重间接性	无严重不精确性	未发现	502/744	724/812	1.32(1.25,1.4)	684/1000	高于219/1000(5,159)	++++中
		痰热互结	温胆汤	心绞痛疗效（11个RCT）	严重局限性	无严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	未发现	337/464	423/466	3.72(2.56,5.42)	726/1000	高于182/1000(145,209)	++++中

				心电图疗效 (12个 RCT)	严重局限性	无严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	未发现	351/525	466/551	2.71 (2.02, 3.64)	669/1000	高于177/1000 (134, 212)	+++—中
				临床疗效 (13个 RCT)	严重局限性	无严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	未发现	378/513	504/542	4.80 (3.25, 7.07)	737/1000	高于194/1000 (164, 215)	+++—中
		痰热互结	小陷胸汤	心绞痛疗效 (1个 RCT)	严重局限性	无严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	未发现	32/50	41/49	1.31 (1.03, 51.67)	640/1000	高于198/1000 (19, 429)	+++—中
				心电图疗效 (1个 RCT)	严重局限性	无严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	未发现	28/50	34/49	1.24 (0.91, 1.69)	560/1000	高于134/1000 (50, 386)	+++—中
		痰热互结	涤痰汤	心电图疗效 (2个 RCT)	有严重局限性	无严重不一致性	有严重间接性	无严重不精确性	未发现	184/255	226/255	1.23 (1.12, 1.34)	712/1000	高于164/1000 (85, 242)	+++—低

	气滞 血瘀	气滞 血瘀	血府 逐瘀 汤	临床症状 有效率（5 个 RCT）	无严重 局限性	无严重 不一致 性	无严重 间接性	无严重 不精确 性	严重 发表偏倚	134/1 88	177/1 90	1.31(1. 18,1.44)	713/10 00	高于 221/10 00 (128,3 14)	+++~ 中
				心电图 有效率（5 个 RCT）	无严重 局限性	无严重 不一致 性	无严重 间接性	无严重 不精确 性	严重 发表偏倚	105/1 88	141/1 90	1.28(1. 06,1.55)	559/10 00	高于 156/10 00 (34,30 7)	+++~ 中
		气滞 血瘀	血府 逐瘀 胶囊	心绞痛 症状缓 解（7 个 RCT）	无严重 局限性	无严重 不一致 性	无严重 间接性	无严重 不精确 性	未发现	174/2 39	219/2 38	1.26(1. 16,1.38)	728/10 00	高于 189/10 00 (116,2 77)	++++ 高
				心电图 改善率 （4 个	无严重 局限性	无严重 不一致 性	无严重 间接性	无严重 不精确 性	未发现	92/13 8	110/1 38	1.20(1. 04,1.38)	667/10 00	高于 133/10 00	++++ 高

				RCT)				性						(27, 25 3)	
缓 解 期	气滞 血瘀	气滞 血瘀	银丹 心脑 通胶 囊	心 绞 痛 疗效 (35 个 RCT)	无 严 重 局限性	无 严 重 不一致 性	无 严 重 间 接 性	无 严 重 不 确 精 性	未 发 现	1421/ 1961	1769/ 2016	1. 21 (1. 17, 1. 25)	725/10 00	高 于 152/10 00 (123, 1 81)	++++ 高
		气滞 血瘀	心可 舒片	心 电 图 疗效 (6 个 RCT)	无 严 重 局限性	无 严 重 不一致 性	无 严 重 间 接 性	无 严 重 不 确 精 性	未 发 现	320/5 17	425/5 25	2. 69 (2. 02, 3. 57)	653/10 00	高 于 182/10 00 (139, 217)	+++-- 中
				临 床 疗 效 (10 个 RCT)	严 重 局 限性	无 严 重 不一致 性	无 严 重 间 接 性	无 严 重 不 确 精 性	未 发 现	581/7 41	708/7 51	4. 69 (3. 28, 6. 72)	769/10 00	高 于 171/10 00 (147, 188)	+++-- 中
		气滞 血瘀	冠心 丹参 滴丸	心 绞 痛 疗效 (13 个 RCT)	有 严 重 局限性	无 严 重 不一致 性	有 严 重 间 接 性	无 严 重 不 确 精 性	未 发 现	518/6 63	694/7 11	1. 17 (1. 11, 1. 22)	766/10 00	高 于 130/10 00 (84, 1 69)	+++-- 低

				心电图疗效(13个RCT)	有严重局限性	无严重不一致性	有严重间接性	无严重不精确性	未发现	353/601	496/648	2.36(1.84,3.02)	517/1000	高于703/1000(434,1000)	+++中
		瘀血痹阻	失笑散	心电图疗效(3个RCT)	严重局限性	无严重不一致性	严重间接性	无严重不精确性	未发现	60/94	92/114	2.47(1.3,4.68)OR	571/1000	高于196/1000(63,291)	+++低
		气滞血瘀	养心达瓦依米西克蜜膏	心电图疗效(1个RCT)	严重局限性	无严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	未发现	32/52	46/56	1.33(1.04,1.71)	615/1000	高于203/1000(25,437)	+++中
				临床疗效(1个RCT)	严重局限性	无严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	未发现	37/52	51/56	1.28(1.06,1.55)	712/1000	高于199/1000(43,392)	+++中
	痰浊闭阻	痰浊闭阻	瓜蒌薤白半夏汤	心绞痛疗效(18个RCT)	无严重局限性	无严重不一致性	有严重间接性	无严重不精确性	未发现	80/108	100/104	2.48(1.22,5.04)	613/1000	高于184/1000(46,276)	+++中
				心电图疗效(19个RCT)	无严重局限性	无严重不一致性	有严重间接性	无严重不精确性	未发现	608/855	809/895	3.86(2.95,5.05)	706/1000	高于197/1000(170,	+++中

														218)	
				证候疗效(4个RCT)	无严重局限性	无严重不一致性	有严重间接性	无严重不精确性	未发现	118/156	164/177	4.68(2.34,9.39)	793/1000	高于154/1000(107,180)	+++—中
		痰瘀互结	丹蒞片	心电图疗效(2个RCT)	无严重局限性	无严重不一致性	严重间接性	严重不精确性	未发现	31/65	40/65	1.29(0.95,2.2)	469/1000	高于138/1000(23,563)	+++—低
	痰浊闭阻	痰热互结	黄连温胆汤	临床疗效(6个RCT)	严重局限性	无严重不一致性	严重间接性	无严重不精确性	未发现	181/260	240/262	1.32(1.12,1.55)	714/1000	高于228/1000(86,393)	+++—中
缓解期	痰浊闭阻	痰热互结	黄连温胆汤	心绞痛疗效(14个RCT)	有严重局限性	无严重不一致性	有严重间接性	无严重不精确性	未发现	347/482	476/508	1.3(1.22,1.38)	713/1000	高于214/1000(157,271)	+++—低
				心电图疗效(7个RCT)	有严重局限性	无严重不一致性	有严重间接性	无严重不精确性	未发现	152/239	230/264	1.36(1.23,1.51)	606/1000	高于218/1000(139,309)	+++—低

	寒凝心脉	寒凝心脉	冠心苏合丸	临床疗效（2个RCT）	无严重局限性	无严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	未发现	76/100	96/103	4.33(1.77,10.59)	758/1000*	高于173/1000(89,213)	++++高
	气虚血瘀	气虚血瘀	八珍汤加減	临床疗效（2个RCT）	严重局限性	无严重不一致性	严重间接性	无严重不精确性	未发现	64/85	78/85	1.22(1.06,1.4)	751/1000	高于166/1000(45,301)	++---低
				心电图疗效（2个RCT）	严重局限性	无严重不一致性	严重间接性	无严重不精确性	未发现	59/85	75/85	1.27(1.08,1.49)	693/1000	高于187/1000(56,340)	++---低
		气虚血滞、脉络瘀阻	脑心通胶囊	不良事件（9个RCT）	无严重局限性	无严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	未发现	1/323	9/328	3.52(1,12.38)	3/1000	低于3/1000(3,3)	++++高
		气虚血瘀	通心络胶囊	临床疗效（7个RCT）	严重局限性	无严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	未发现	199/72	257/80	1.26(1.16,1.36)	732/1000	高于190/1000(117,263)	++++中

缓 解 期	气虚血瘀		养心氏片	心绞痛疗效（7个RCT）	有严重局限性	无严重不一致性	有严重间接性	无严重不精确性	未发现	303/382	507/538	3.93(2.51,6.16)	789/1000	高于147/1000（115,169）	+++--低
			养心氏片	心电图疗效（8个RCT）	有严重局限性	无严重不一致性	有严重间接性	无严重不精确性	未发现	250/53	309/36	2.46(1.69,3.59)	727/1000	高于141/1000（91,178）	+++--低
		气虚血瘀	麝香通心滴丸	心绞痛症状总有效率（9个RCT）	无严重局限性	无严重不一致性	严重间接性	无严重不精确性	未发现	327/424	397/429	3.89(2.52,6.01)	771/1000	高于158/1000（123,182）	+++--中
				心电图改善总有效率（4个RCT）	无严重局限性	无严重不一致性	严重间接性	无严重不精确性	未发现	140/28	190/30	3.25(2.06,5.12)	614/1000	高于224/1000（152,277）	+++--中
		气虚血瘀	麝香通心滴丸	心绞痛症状显效率（8个RCT）	无严重局限性	无严重不一致性	严重间接性	无严重不精确性	未发现	146/89	244/91	3.05(2.24,4.14)	375/1000	高于272/1000（198,338）	+++--中
				心电图改善显效率（4个RCT）	无严重局限性	无严重不一致性	严重间接性	无严重不精确性	未发现	70/228	102/30	1.97(1.30,2.98)	307/1000	高于159/1000（58,26	+++--中

														2)	
		气虚血瘀	血栓心脉宁片	心绞痛疗效（7个RCT）	严重局限性	无严重不一致性	严重间接性	无严重不精确性	高度怀疑	315/432	374/424	2.6(1.82,3.73) OR	763/1000	高于130/1000（91,160）（1000,1000）	+++--低
				心电图疗效（4个RCT）	严重局限性	无严重不一致性	严重间接性	无严重不精确性	高度怀疑	208/274	229/266	1.98(1.26,3.09) OR	763/1000	高于101/1000（39,146）	+++--低
		气虚血瘀	愈心痛胶囊	硝酸甘油减停（2个RCT）	无严重局限性	无严重不一致性	有严重间接性	无严重不精确性	未发现	29/58	102/123	1.55(1.17,2.04)	504/1000	高于277/1000（86,524）	+++--中
				心电图疗效（2个RCT）	无严重局限性	无严重不一致性	有严重间接性	无严重不精确性	未发现	34/60	106/135	1.37(1.06,1.77)	567/1000	高于210/1000（34,437）	+++--中
		气虚血瘀	参桂胶囊	心电图疗效（3个RCT）	严重局限性	无严重不一致性	严重间接性	无严重不精确性	未发现	115/169	147/174	1.24(1.1,1.4)	609/1000	高于146/1000（61,224）	+++--中

				临床疗效 (2 个 RCT)	严重局限性	无严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	未发现	63/104	97/107	1.5 (1.27, 1.77)	608/1000	高于 304/1000 (164, 468)	++++中
		气虚下陷	升陷汤	不良反应 (2 个 RCT)	无严重局限性	无严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	未发现	7/65	0/65	0.11 (0.01, 0.92)	107/1000	低于 94/1000 (8, 106)	++++高
				临床疗效 (2 个 RCT)	无严重局限性	无严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	未发现	51/65	62/65	5.79 (1.56, 21.48)	781/1000	高于 173/1000 (67, 206)	++++高
		气阴两虚, 心络瘀阻	参松养心胶囊	心电图疗效 (4 个 RCT)	无严重局限性	无严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	未发现	125/172	157/182	2.40 (1.4, 4.11)	722/1000	高于 138/1000 (62, 189)	++++高
				临床疗效 (5 个 RCT)	无严重局限性	无严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	未发现	174/218	195/218	2.18 (1.26, 3.79)	798/1000	高于 98/1000 (35, 139)	++++高
缓解期	气阴两虚	气阴两虚	生脉注射液	临床疗效 (9 个 RCT)	严重局限性	无严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	未发现	337/460	430/472	1.24 (1.17, 1.32)	733/1000	高于 176/1000 (125, 2	++++中

														34)	
		气阴 两虚	通脉 养心 丸	心绞痛 改善（9 个RCT）	无严重 局限性	无严重 不一致 性	有严重 间接性	无严重 不精确 性	未发现	291/4 22	379/4 50	1.22(1. 13,1.31)	728/10 00	高于 160/10 00 (95,2 26)	++++ 中
				心电图 疗效（2 个RCT）	无严重 局限性	无严重 不一致 性	有严重 间接性	无严重 不精确 性	未发现	232/3 42	324/3 70	1.31(1. 21,1.42)	694/10 00	高于 215/10 00 (146, 291)	++++ 中
		气阴 两虚	灯盏 生脉 胶囊	临床症 状显效 率（13 个RCT）	无严重 局限性	无严重 不一致 性	无严重 间接性	无严重 不精确 性	未发现	229/5 64	317/6 07	1.81(1. 39,2.36)	406/10 00	高于 147/10 00 (81,21 1)	++++ 高
				心电图 疗效显 效率（12 个RCT）	无严重 局限性	无严重 不一致 性	无严重 间接性	无严重 不精确 性	未发现	168/5 23	244/5 66	1.89(1. 41,2.53)	321/10 00	高于 151/10 00 (79,22 4)	++++ 高
				心绞痛 住院发 生率（4 个RCT）	无严重 局限性	无严重 不一致 性	无严重 间接性	无严重 不精确 性	未发现	28/16 6	15/16 6	0.49(0. 25,0.95)	169/10 00	低于 78/100 0 (7,120)	++++ 高
				心肌梗 死发生	无严重 局限性	无严重 不一致 性	无严重 间接性	无严重 不精确 性	未发现	18/16 6	7/166	0.36(0. 15,0.89)	108/10 00	低于 66/100	++++ 高

				率 (4 个 RCT)		性	接性	精 确 性				)		0 (11,91)	
		气阴两虚	益心舒丸	心绞痛改善总有效率 (11 个 RCT)	严重局限性 1	无严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	未发现	587/773	956/1054	0.30 (0.23, 0.40)	759/1000	低于 273/1000 (201,339)	+++ 中
				心电图改善总有效率 (10 个 RCT)	严重局限性 1	无严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	未发现	456/675	752/955	0.52 (0.41, 0.66)	676/1000	低于 156/1000 (97,215)	+++ 中
		气阴两虚	养心生脉颗粒	临床疗效 (2 个 RCT)	严重局限性	无严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	未发现	76/94	90/94	5.34 (1.73, 16.51) OR	808/1000	高于 149/1000 (71,178)	++ 低
	心肾阴虚	心肾阴虚、心血瘀阻	心元胶囊	心绞痛疗效 (6 个 RCT)	严重局限性	无严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	未发现	173/231	357/383	4.94 (2.94, 8.28) OR	729/1000	高于 201/1000 (159,228)	+++ 中
				心电图疗效 (6 个 RCT)	严重局限性	无严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	未发现	113/224	280/376	2.7 (1.38, 2.86) OR	694/1000	高于 228/1000 (80,239)	+++ 中

缓 解 期	心肾 阴虚		酸枣 仁汤	临 床 有 效 率 (28 项 RCT)	无 严 重 局 限 性	无 严 重 不 一 致 性	无 严 重 间 接 性	无 严 重 不 确 性	未 发 现	1021/ 1349	1262/ 1402	3.12(2. 41,4.03)	745/10 00	高 于 156/10 00 (131, 177)	+++ - 中
			黄 连 阿 胶 汤	心 绞 痛 疗 效 (14 个 RCT)	有 严 重 局 限 性	无 严 重 不 一 致 性	有 严 重 间 接 性	无 严 重 不 确 性	未 发 现	347/4 82	476/5 08	1.3(1.2 2,1.38)	713/10 00	高 于 214/10 00 (157, 271)	+++ - 低
				心 电 图 疗 效 (7 个 RCT)	有 严 重 局 限 性	无 严 重 不 一 致 性	有 严 重 间 接 性	无 严 重 不 确 性	未 发 现	152/2 39	230/2 64	1.36(1. 23,1.51)	60.6/1 000	高 于 218/10 00 (139, 309)	+++ - 低
			天 王 补 心 丹	心 绞 痛 疗 效 (3 个 RCT)	有 严 重 局 限 性	有 严 重 不 一 致 性	有 严 重 间 接 性	无 严 重 不 确 性	未 发 现	45/81	109/1 16	1.65(1. 36,2.01)	680/10 00	高 于 442/10 00 (245, 687)	+ --- 极 低
				心 电 图 疗 效 (3 个 RCT)	有 严 重 局 限 性	无 严 重 不 一 致 性	有 严 重 间 接 性	无 严 重 不 确 性	未 发 现	33/74	86/11 4	1.74(1. 32,2.3)	467/10 00	高 于 346/10 00 (149, 607)	+++ - 低
	心肾 阳虚	心肾 阳虚	真武 汤	总 有 效 率 (13 个 RCT)	无 严 重 局 限 性	无 严 重 不 一 致 性	无 严 重 间 接 性	无 严 重 不 确 性	未 发 现	356/4 50	490/5 33	1.16(1. 1,1.22)	791/10 00	高 于 127/10 00 (79,17	+++ - 中

														4)	
		阳气暴脱	参附注射液	心绞痛疗效(16个RCT)	严重局限性	无严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	未发现	350/482	442/610	3.38(2.47, 4.64)	728/1000	高于1000/1000(1000, 1000)	++++中
				心电图疗效(9个RCT)	严重局限性	无严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	未发现	179/374	243/297	3.3(2.2, 4.9)	600/1000	高于1000/1000(584, 1000)	++++中
				不良事件(5个RCT)	严重局限性	无严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	未发现	19/218	26/269	0.89(0.18, 4.25)	67/1000	低于7/1000(55, 218)	++++中
非药物治疗			内关穴	心绞痛有效性(3个RCT)	无严重局限性	无严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	未发现	91/117	123/127	1.25(1.12, 1.38)	778/1000	高于194/1000(93, 296)	++++高
			膻中穴	心绞痛改善(8个RCT)	有严重局限性	无严重不一致性	有严重间接性	无严重不精确性	未发现	307/386(79.5%)	408/437(93.4%)	1.17(1.11, 1.24)	761/1000	高于129/1000(84, 183)	++--低
				心电图疗效(6个RCT)	有严重局限性	无严重不一致性	有严重间接性	无严重不精确性	未发现	193/286(67.5%)	272/345(78.8%)	1.21(1.1, 1.33)	677/1000	高于142/1000	++--低

						性						(68,2 23)	
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	---------------	--

表 4 证据概要总结表（连续性变量）
冠心病稳定型心绞痛的 GRADE 证据概要表

分期	归属证候	主治证候	药物名称	质量评价						结果总结			
				研究数量及设计	局限性	不一致性	间接性	不精确性	发表偏倚	病例数		均差 MD (95%CI)	质量
										对照组	试验组		
缓解期	心血瘀阻	痰热互结	温胆汤	TC（6 个 RCT）	严重局限性	无严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	未发现	310	310	低于 0.70 (0.52, 0.89)	+++—中
				TG（6 个 RCT）	严重局限性	严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	未发现	310	310	低于 0.48 (0.21, 0.76)	+++—低
				LDL（6 个 RCT）	严重局限性	严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	未发现	310	310	低于 0.67 (0.01, 1.36)	+++—低
				HDL（6 个 RCT）	严重局限性	严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	未发现	310	310	0.29(0.03, 0.55)	+++—低
		痰热互结	小陷胸汤	心绞痛发作频率（1 个 RCT）	严重局限性	无严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	未发现	50	49	低于 1.27 (0.54, 2)	+++—中
				心绞痛持续时间（1 个 RCT）	严重局限性	无严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	未发现	50	49	高于 0.49 (0.6, 1.58)	+++—中
				IL-6	严重局限性	无严重不一致性	严重间接性	无严重不精确性	未发现	82	81	低于 2.98 (2.12, 3.85)	+++—低
				hs-CRP	严重局限性	无严重不一致性	严重间接性	无严重不精确性	未发现	82	81	低于 1.83 (1.44, 2)	+++—低

											22)	
	痰热互结	涤痰汤	GRACE (2 个 RCT)	有严重局限性	无严重不一致性	有严重间接性	无严重不精确性	未发现	110	110	低于 10.12 (7.98, 12.26)	+++—低
			SAQ (2 个 RCT)	有严重局限性	无严重不一致性	有严重间接性	无严重不精确性	未发现	110	110	低于 11.6 (10.13, 13.07)	+++—低
			心绞痛评分 (5 个 RCT)	有严重局限性	有严重不一致性	有严重间接性	有严重不精确性	未发现	98	96	低于 0.12 (1.61, 1.86)	+++—极低
气滞血瘀	气滞血瘀	心可舒	总胆固醇 (7 个 RCT)	无严重局限性	严重不一致性	严重间接性	无严重不精确性	未发现	310	325	低于 0.87 (0.47, 1.28)	+++—低
			低密度脂蛋白 (7 个 RCT)	无严重局限性	严重不一致性	严重间接性	无严重不精确性	未发现	310	325	低于 0.77 (0.32, 1.22)	+++—低
			高密度脂蛋白 (6 个 RCT)	无严重局限性	无严重不一致性	严重间接性	无严重不精确性	未发现	268	283	高于 0.11 (0.02, 0.17)	+++—中
	气滞血瘀	冠心丹参滴丸	全血粘度 (5 个 RCT)	有严重局限性	有严重不一致性	有严重间接性	无严重不精确性	未发现	156	177	低于 0.86 (0.28, 1.43) WMD	+++—极低
			血浆粘度 (5 个 RCT)	有严重局限性	有严重不一致性	有严重间接性	无严重不精确性	未发现	156	177	低于 0.35 (0.15, 0.56) WMD	+++—极低
			红细胞压积 (4 个 RCT)	有严重局限性	无严重不一致性	有严重间接性	无严重不精确性	未发现	109	129	低于 3.30 (2.53, 4.07)	+++—低

												07) WMD	
				纤维蛋白原(5个RCT)	有严重局限性	无严重不一致性	有严重间接性	无严重不精确性	未发现	156	177	低于 0.76 (0.48, 1.05) WMD	+++—低
	痰热互结	痰热互结	黄连温胆汤	胆固醇(4个RCT)	有严重局限性	有严重不一致性	有严重间接性	无严重不精确性	未发现	199	200	低于 0.97 (0.87, 1.06)	+——极低
				CRP (5个RCT)	有严重局限性	无严重不一致性	有严重间接性	无严重不精确性	未发现	214	215	低于 4 (3.57, 4.43)	+++—低
				中医证候积分(3个RCT)	有严重局限性	无严重不一致性	有严重间接性	无严重不精确性	未发现	113	132	低于 1.79 (0.97, 2.61)	+++—低
				发作频率(5个RCT)	有严重局限性	无严重不一致性	有严重间接性	无严重不精确性	未发现	174	175	低于 1.5 (1.38, 1.61)	+++—低
	缓解期	寒凝心脉	冠心苏合丸	心绞痛发作频率(2个RCT)	无严重局限性	无严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	未发现	100	103	低于 2.21 (1.85, 2.56)	++++高
				心绞痛发作时间(2个RCT)	无严重局限性	无严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	未发现	100	103	低于 1.15 (1.02, 1.27)	++++高
				胸痛症状评分(2个RCT)	无严重局限性	无严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	未发现	100	103	低于 0.8 (0.58, 1.02)	++++高
				胸闷症状评分(2个RCT)	无严重局限性	无严重不一致性	无严重间接性	严重不精确性	未发现	100	103	低于 0.77 (0.52, 1.01)	+++—中

				气短症状评分（2个 RCT）	无严重局限性	无严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	未发现	100	103	低于 0.36 (0.23, 0.95)	++++高
				心悸症状评分（2个 RCT）	无严重局限性	无严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	未发现	100	103	低于 0.77 (0.34, 1.19)	++++高
	气虚血瘀	气虚血滞	脑心通胶囊	总胆固醇（9个 RCT）	无严重局限性	严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	未发现	833	850	低于 0.63 (0.53, 0.74)	++++中
				高密度脂蛋白（9个 RCT）	无严重局限性	严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	未发现	833	850	0.2(0.15, 0.26)	++++中
				低密度脂蛋白（9个 RCT）	无严重局限性	严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	未发现	833	850	低于 0.66 (0.53, 0.79)	++++中
		气虚血瘀	通心络胶囊	LDL-C（4个 RCT）	无严重局限性	无严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	未发现	175	175	低于 0.25 (0.12, 0.39)	++++高

				SDP (6 个 RCT)	无严重局 限性	无严重不 一致性	无严重间 接性	无严重不 精确性	未发现	228	236	低于 5.69 (2.06,9.3 3)	++++高
		养心 氏片	胆固醇(2 个 RCT)	有严重局 限性	有严重不 一致性	有严重间 接性	无严重不 精确性	未发现	171	327	低于 0.76 (0.23,1. 29) WMD	----极 低	
			甘油三酯(3 个 RCT)	有严重局 限性	有严重不 一致性	有严重间 接性	无严重不 精确性	未发现	201	357	低于 0.77 (0.2,1.3 4) WMD	----极 低	
			低密度脂蛋白(3 个 RCT)	有严重局 限性	无严重不 一致性	有严重间 接性	无严重不 精确性	未发现	69	69	低于 1.85 (1.92,1. 77) WMD	+++--低	
			超敏 C 反应蛋白 (2 个 RCT)	有严重局 限性	有严重不 一致性	有严重间 接性	无严重不 精确性	未发现	128	130	低于 1.23 (0.25,2. 21) WMD	----极 低	
			DBP (6 个 RCT)	无严重局 限性	无严重不 一致性	无严重间 接性	无严重不 精确性	未发现	228	236	低于 2.14(0.98 ,3.31)	++++高	
缓 解 期	气 虚 血 瘀	气 虚 血 瘀	愈心 痛胶 囊	全血粘度 高切 (2 个 RCT)	无严重局 限性	无严重不 一致性	有严重间 接性	无严重不 精确性	未发现	60	135	低于 0.99 (0.76,1. 23)	+++--中
				全血粘度 低切 (5 个 RCT)	无严重局 限性	无严重不 一致性	有严重间 接性	无严重不 精确性	未发现	60	135	低于 0.31 (0.43,1. 05)	+++--低

	气阴两虚	气阴两虚	生脉注射液	高敏C反应蛋白（3个RCT）	严重局限性	严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	未发现	145	153	低于4.46(2.12,6.97)	+++—低
				血浆黏度（2个RCT）	严重局限性	无严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	未发现	96	96	低于0.11(0.03,0.18)	+++—中
		气阴两虚	养心生脉颗粒	心绞痛次数（1个RCT）	严重局限性	无严重不一致性	严重间接性	无严重不精确性	未发现	48	48	低于3.68（3.6,3.76）	+++—低
				心绞痛持续时间（1个RCT）	严重局限性	无严重不一致性	严重间接性	无严重不精确性	未发现	48	48	低于2.32（2.2,2.32）	+++—低
				LVEF（2个RCT）	严重局限性	无严重不一致性	严重间接性	无严重不精确性	未发现	94	94	高于9.63（6.95,8.31）	+++—低
				LVESD（2个RCT）	严重局限性	无严重不一致性	严重间接性	无严重不精确性	未发现	92	94	低于4.79（4.31,5.28）	+++—低
		心肾阴虚	酸枣仁汤	PSQI（6个RCT）	严重局限性	有严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	未发现	308	315	低于1.38（0.86,1.9）SMD	+++—低
				SPIEGEL疗效评价（7个RCT）	严重局限性	有严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	未发现	324	343	高于0.85（0.19,1.5）SMD	+++—低
			黄连阿胶汤	胆固醇（4个RCT）	有严重局限性	无严重不一致性	有严重间接性	无严重不精确性	未发现	199	200	低于0.97（0.87,1.06）	+++—低

				CRP（5 个 RCT）	有严重局限性	无严重不一致性	有严重间接性	无严重不精确性	未发现	214	215	低于 4 （3.57, 4.43）	+++—低
				中医证候积分（3 个 RCT）	有严重局限性	无严重不一致性	有严重间接性	无严重不精确性	未发现	113	132	低于 1.79 （0.97, 2.61）	+++—低
				发作频率（5 个 RCT）	有严重局限性	无严重不一致性	有严重间接性	无严重不精确性	未发现	174	175	低于 1.5 （1.38, 1.61）	+++—低
				持续时间（5 个 RCT）	有严重局限性	无严重不一致性	有严重间接性	无严重不精确性	未发现	174	175	低于 1.1 （1.02, 1.18）	+++—低
	心肾阳虚	心肾阳虚	真武汤	射血分数 LVEF（8 个 RCT）	无严重局限性	严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	未发现	300	358	7.12（3.98, 10.27）	++++—中
				心搏量指数（4 个 RCT）	无严重局限性	无严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	未发现	178	217	6.92（5.21, 8.62）	++++—高
				每搏输出量（6 个 RCT）	无严重局限性	严重不一致性	无严重间接性	无严重不精确性	未发现	246	287	11.18（6.04, 16.33）	+++—中
				心脏指数（4 个 RCT）	无严重局限性	严重不一致性	无严重间接性	严重不精确性	未发现	178	200	0.50（0, 1.3）	+++—低
非药物治疗法			太极拳	最大摄氧量（4 个 RCT）	严重局限性	严重不一致性	严重间接性	无严重不精确性	未发现	88	148	高于 2.22 （0.81, 3.63）	+++—极低
			八段锦	METs（3 个 RCT）	无严重局限性	有严重不一致性	有严重间接性	有严重不精确性	未发现	116	116	高于 0.54 （0.07, 1.14）	+++—极低
				6MWT（3 个 RCT）	无严重局限性	有严重不一致性	有严重间接性	无严重不精确性	未发现	159	162	高于 51.38 （22.79, 7	+++—低

										9.98)	
非药物治疗法	八段锦	LVEF (4 个 RCT)	无严重局限性	无严重不一致性	有严重间接性	无严重不精确性	未发现	250	253	高于 3.37 (2.30, 4.43)	+++—中
		NT-proBNP (5 个 RCT)	无严重局限性	无严重不一致性	有严重间接性	无严重不精确性	未发现	213	215	低于 97.17 (84.04, 110.30)	+++—中

附件 6:

冠心病稳定型心绞痛发作期推荐 GRADE 网格

例 1：对于冠心病稳定型心绞痛的成年人群，当心绞痛急性发作时，建议服用速效救心丸。

项目	等级分数				
	2	1	0	-1	-2
干预措施的利弊权衡 (有效性与安全性)	明显利大于弊	可能利大于弊	利弊相当或不确定	可能弊大于利	明显弊大于利
患者的价值观与意愿 (可接受性)	明显可以接受	可能可以接受	不确定能否接受	可能不能接受	明显不能接受
需要的临床条件与实践中的差距 (可行性)	明显可行	可能可行	不确定是否可行	可能不可行	明显不可行
地域符合情况 (地域特殊性)	明显相符	可能相符	不确定是否相符	可能不相符	明显不相符
医保成本 (卫生经济学指标)	明显效益超过成本	可能效益超过成本	不确定成分与效益	可能成本超过效益	明显成本超过效益
拟推荐意见	强推荐	弱推荐	无明确	弱不推荐	强不推荐
其他意见:					

附件 7:

冠心病稳定型心绞痛缓解期推荐 GRADE 网格

例 2: 对于冠心病稳定型心绞痛的成年人群, 当缓解期诊断为心血瘀阻证时, 建议服用冠心 2 号方.

项目	等级分数				
	2	1	0	-1	-2
干预措施的利弊权衡 (有效性与安全性)	明显利大于弊	可能利大于弊	利弊相当或不确定	可能弊大于利	明显弊大于利
患者的价值观与意愿 (可接受性)	明显可以接受	可能可以接受	不确定能否接受	可能不能接受	明显不能接受
需要的临床条件与实践中的差距 (可行性)	明显可行	可能可行	不确定是否可行	可能不可行	明显不可行
地域符合情况 (地域特殊性)	明显相符	可能相符	不确定是否相符	可能不相符	明显不相符
医保成本 (卫生经济学指标)	明显效益超过成本	可能效益超过成本	不确定成分与效益	可能成本超过效益	明显成本超过效益
拟推荐意见	强推荐	弱推荐	无明确	弱不推荐	强不推荐
其他意见:					

